

Bruxismo: día vs. noche

Guía para identificar tu tipo de bruxismo y entender los tratamientos reales, basada en consenso científico internacional y literatura 2025.

¿Qué es el bruxismo?

El bruxismo es la actividad repetitiva de los músculos de la masticación, caracterizada por apretar o rechinar los dientes, y/o por tensar o proyectar la mandíbula. El consenso científico internacional más reciente (2025) establece algo clave: el bruxismo no es, en sí mismo, una enfermedad — es un comportamiento motor. El problema clínico no es que ocurra, sino cuánto daño y qué síntomas está generando en cada persona.

Existen dos formas clínicamente distintas, según el momento en que ocurren:

1. Bruxismo del sueño

Ocurre durante el sueño, de forma involuntaria. Los músculos masetero y temporal —los principales músculos elevadores de la mandíbula— generan contracciones rítmicas breves. La evidencia actual lo describe como un fenómeno mediado principalmente por el sistema nervioso central: la mayoría de los episodios se asocian a micro-despertares del sueño, activaciones breves de pocos segundos que forman parte de la arquitectura normal del sueño, pero que en algunas personas gatillan esta actividad muscular. Factores como el consumo de cafeína, alcohol, el reflujo gastroesofágico, la apnea del sueño y el estrés pueden aumentar su frecuencia.

2. Bruxismo de vigilia

Ocurre despierto, generalmente como apriete sostenido (no rítmico) de los dientes, sin que la persona lo note. Los mismos músculos —masetero y temporal— permanecen contraídos por periodos más largos. La evidencia de los últimos años confirma una asociación directa y consistente con el estrés psicológico y la ansiedad, siendo más frecuente en momentos de alta concentración o tensión emocional.

¿Cómo saber si es tuyo es de día o de noche?

Señal	Sugiere bruxismo del SUEÑO	Sugiere bruxismo de VIGILIA
Cuándo lo notas	Al despertar	Durante el día, al concentrarte o estresarte
Dolor de mandíbula matinal	Frecuente	Poco común
Dolor de cabeza al despertar	Frecuente (dolor en sienes)	Rara vez al despertar
Alguien te ha escuchado rechinar	Sí, mientras duermes	No aplica (no hace ruido, es apriete)
Sensación de mandíbula tensa	Al despertar, mejora durante el día	Aparece y aumenta durante el día

Esta tabla es orientativa, no reemplaza una evaluación clínica. Muchas personas presentan ambos tipos combinados.

El daño: no es el mismo para todos

Las consecuencias del bruxismo dependen del área afectada, y por eso el tratamiento no puede ser genérico:

Dientes: Desgaste progresivo del esmalte, fracturas de piezas dentales y de restauraciones existentes (resinas, coronas). El esmalte, a diferencia de otros tejidos, no se regenera: el daño ya ocurrido requiere tratamiento restaurador aparte.

Músculos (masetero, temporal, pterigoideos): Dolor muscular (mialgia), fatiga mandibular, y en casos crónicos, dolor miofascial persistente que puede irradiar hacia la sien generando dolores de cabeza tensionales.

Articulación temporomandibular (ATM): Dolor articular, chasquidos, limitación de apertura bucal y, en casos persistentes, cambios degenerativos de la articulación.

Tratamiento: lo que la evidencia 2025 realmente respalda

Lo que casi nadie explica con claridad: una placa de descarga no detiene el bruxismo. Protege los dientes redistribuyendo la fuerza de la mordida y evitando que el desgaste siga avanzando sobre el esmalte natural, pero no elimina la actividad muscular de fondo. Estudios recientes con ultrasonografía muestran que las placas reducen la tensión y el grosor muscular medible, pero la actividad parafuncional puede persistir.

Cuando el problema principal es dolor muscular persistente o dolores de cabeza asociados, la evidencia actual —incluyendo revisiones sistemáticas y ensayos clínicos de 2024-2025— respalda sumar toxina botulínica en los músculos masetero y temporal: bloquea la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular, reduce directamente la hiperactividad muscular, y ha mostrado reducciones de hasta 87% en episodios de bruxismo y mejoras significativas en el dolor en los estudios más recientes.

Cuando el dolor está en la articulación, la placa ayuda a redistribuir la carga articular; en casos persistentes se evalúa junto a terapia física específica de ATM. En resumen: **no existe un tratamiento único para todos** — la combinación depende de qué estructura está siendo afectada y qué tan severo es el cuadro.

Referencias — literatura gris internacional y organizaciones

Este contenido se elaboró con base en publicaciones y consensos internacionales actualizados sobre bruxismo y trastornos temporomandibulares (TMD):

1. Verhoeff MC, Lobbezoo F, et al. *Updating the Bruxism Definitions: Report of an International Consensus Meeting*. Consenso cerrado de la International Association for Dental Research (IADR). Journal of Oral Rehabilitation, 2025.
2. Lobbezoo F, Ahlberg J, Raphael KG, et al. *International consensus on the assessment of bruxism: Report of a work in progress*. Journal of Oral Rehabilitation, 2018.
3. American Academy of Sleep Medicine (AASM). *International Classification of Sleep Disorders*, 3ª edición, revisión de texto (ICSD-3-TR) — criterios diagnósticos vigentes para bruxismo relacionado con el sueño, 2023.
4. Schiffman E, Ohrbach R, Truelove E, et al. *Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for Clinical and Research Applications*. Recomendaciones del International RDC/TMD Consortium Network y el Orofacial Pain Special Interest Group de la International Association for the Study of Pain (IASP). Journal of Oral & Facial Pain and Headache, 2014 (protocolo diagnóstico de referencia, vigente y adoptado internacionalmente).
5. American Academy of Orofacial Pain (AAOP). *Guidelines for the Assessment, Diagnosis, and Management of Orofacial Pain and Temporomandibular Disorders*, 7ª edición — incorpora la definición actualizada de bruxismo por consenso internacional.
6. Balasubramaniam R, et al. *Sleep Bruxism: A Narrative Review of Current Concepts, Mechanisms, and Clinical Implications*. Journal of the Royal Society of New Zealand, 2025/2026.
7. *Bruxism treatment outcomes: A systematic review and meta-analysis*. Medicine (Lippincott Williams & Wilkins), 2025.
8. *Efficacy of botulinum toxin type A in bruxism management: A systematic review*. Dental Medicine Problems, 2025;62(1):145.
9. *Efficacy and Safety of Botulinum Toxin in the Management of Temporomandibular Symptoms Associated with Sleep Bruxism: A Systematic Review*. Dentistry Journal (MDPI), 2024.
10. *Botulinum toxin in masticatory disorders: Clinical efficacy, adaptive responses, and therapeutic considerations — a systematic review*. ScienceDirect, 2025/2026.
11. *The effectiveness of botulinum toxin for temporomandibular disorders: A systematic review and meta-analysis*. PLOS ONE, 2024.
12. *Centric stabilization occlusal splints vs. other conservative therapies in the management of temporomandibular disorders: a systematic review and meta-analysis*. PMC, 2025.
13. *Effects of occlusal splint therapy on the masseter and temporalis muscles in female patients with myofascial pain syndrome: An ultrasonographic study*. 2025.

Este material tiene fines educativos y no reemplaza una evaluación clínica presencial. Cada caso de bruxismo requiere diagnóstico individual para determinar el tratamiento adecuado.

**¿Quieres saber si tu bruxismo es de día o de noche, y qué tratamiento te corresponde?
Escríbenos por WhatsApp y agenda una evaluación con el Dr. Nicolás Guzmán.**

Dr. Nicolás Guzmán — Odontólogo · Aníbal Pinto 295, Edificio Buró, Of. 303, Concepción · WhatsApp: wa.link/tu8qmu · Instagram: @ndguzmanl